

05 - Le Cancer de la Vulve - Pr. FAKHIR

Bonjour. Le cours d'aujourd'hui, c'est le concert de la vulve sur la femme, bien sûr. Donc, c'est un cours qui fait partie de l'adulte de gynécologie obstétrique de la 5ème année des études médicales.

Par définition, le concert de la vulve est une prolifération néoplasique, on va dire, qui se développe sur l'ensemble des formations génitales externes de la femme. Alors, l'épithéliologie pauvre, patieuse, c'est une pathologie peu fréquente, c'est une pathologie qui a une prédominance particulière chez les femmes très âgées. A côté de cela, on définit ce qu'on appelle les VIN, vulvale intra-épithélia néoplasme, qui sont des lésions précurseurs du concert négatif et qui sont plus fréquentes.

Ces VIN, ce sont des développements d'atypies cellulaires à l'intérieur de l'épithélium de la vulve, généralement de l'épithélium épidermique. Et donc, comme je dis, c'est des précurseurs du concert, c'est-à-dire des lésions préconsérentes. Concernant l'incidence, au Maroc, et selon le registre des concerts de nuit de 2012, de Canca de Bianca, eh bien, l'incidence est à peu près 1 sur 100 000 femmes, à peu près 0,8% du concert de la femme, et il s'agit du quatrième concert gynécologique.

Si on regarde un peu la courbe à droite, il ne peut pas représenter, ce qui veut dire que l'incidence est très faible. Et donc, en regardant les chiffres, on trouve qu'il y a une disparité, qu'il y a une différence entre les pays, allant de 2 à 2,6% des femmes au Canada, jusqu'à 0,17% des femmes, donc au Garond, et ceci peut aussi être lié à l'espérance de vie de certains pays développés qui font que les femmes vivent un peu plus longtemps, et donc ont plus de risque de faire un concert de la femme. Le concert invasif de la vulve est un concert de la femme âgée, et donc la moyenne d'âge est entre 63 et 66 ans, avec, par exemple, en Garond, une moyenne de 52 ans, avec des extrêmes de 49 à 72 ans.

Les VIN, ou les régions ouvertes intra-épidémiales, et les concerts invasifs ont une distribution différente, donc on voit que les VIN sont beaucoup plus fréquentes vers les âges plus jeunes, notamment entre 40 et 49 ans, puis diminuent après pour donner place aux concerts invasifs. Et puis, il y a le concert in situ, et généralement, 50% sont diagnostiqués chez les femmes de moins de 40 ans. Les concerts in situ veulent dire des lésions intra-épidémiales type VIN, mais qui concernent la totalité de la hauteur de l'épidémie en marge ouverte.

Sur le plan anatomique, la vulve, comme on a dit tout à l'heure, c'est les organes génitaux externes qui apparaissent à la peau si on élimine la vis. De haut en bas, on trouve la région du monde du pubis, on retrouve le clitoris qui est au milieu, on retrouve de part et d'autre les formations labiales, et donc les grandes lèvres vers l'extérieur, qui sont cutanées, glares, et qui sont poilues en général. Leur face interne est délimitée par un sillon interlabial qui les sépare des petites lèvres qui sont plus internes, qui sont cutanées aussi, mais qui ne partiment que à leur

face interne, et qui délimitent de part et d'autre le vestibule génital, avec une commissure postérieure en arrière, et avec une insertion au niveau du clitoris en avant.

Puis on retrouve les glandes vulgaires qui se trouvent de part et d'autre dans le vestibule postérieur, et qui sont donc les glandes de part et d'autre de l'orifice pluri-uréthral et du rétro-urétral, et bien on retrouve les glandes de Skene. Et donc si on observe correctement, on retrouve qu'il y a plusieurs éléments constitutifs de la vulve, notamment des éléments cutanés, notamment dans les grandes lèvres et petites lèvres, qui peuvent être le siège de formation cancéreuse à partir des éléments cutanés, et donc la vulve peut être concernée par tous les types d'histologie qui surviennent au niveau de la peau. Et puis il y a une partie muqueuse, sur les faces internes des petites lèvres, ainsi que l'orifice vaginal, l'orifice externe du vagin, qui sont d'origine muqueuse, et donc on peut aussi avoir des adénocarcinomes, donc des carcinomes glandulaires.

Puis il y a des formations glandulaires, comme on a dit, les glandes de part et d'autre de l'animal de Skene, qui elles aussi peuvent être responsables ou être le siège de formation carcinomateuse spécifique, ce qui fait que la région de la vulve est une région qui est riche anatomiquement et histologiquement, et de ce fait, les différents types histologiques qui peuvent survenir dans cette région sont assez nombreux. Toujours dans les rappels anatomiques, la vulve est tendue aussi à la région du périnée superficiel, si on retire la peau, on retrouve ce qu'on appelle les corps aéroïdes, par contre d'autres membres de la vulve, qui sont les labes, les sponges et les corps vermineux, et qui eux aussi peuvent être, justement, sièges de développement carcinomateux, puisque ce sont des structures très vascularisées, ça peut être les sponges, les sarcomes, par exemple. Il y a aussi les parties musculaires sous-cutanées, qui sont juste sous la peau, et là aussi elles peuvent être l'origine de les tumeurs sarcomateuses, comme les tumeurs sarcomes ou les tumeurs sarcomes, et il y a bien sûr les tissus conjonctifs et tissus graisseux qui sont cutanés, et donc là aussi on peut voir des sarcomes dans le tissu graisseux ou conjonctif.

La vascularisation de la vulve, donc on sait qu'elle est d'origine iliaque, interne, et qui, dans sa partie postérieure, est par les vaisseaux pudendaux internes, et par la vascularisation fémorale, qui est d'origine iliaque externe, à partir des pudendaux, et ceci est sur la vascularisation de la partie antérieure, donc des lèvres. Et donc sur le plan histologique, la vulve contient plusieurs tissus, le revêtement cutané, les tissus longs-angulaires, les tissus cellulaires graisseux, les tissus musculaires, et les muqueuses. De ce fait, on va retrouver plusieurs types histologiques de cancers de la vulve.

Le plus fréquent, et donc à 90% du cas, c'est les carcinomes épidermiques, les spinocellulaires, donc on dépend de la peau de l'épiderme alpinique. Puis on peut avoir plusieurs autres cancers comme les carcinomes vésicaux, les mélanomes, les sarcomes, les cancers vasocellulaires, la maladie pagée de la grue, les adénocarcinomes portés de tissus coloniaux, et d'autres types histologiques. Donc pour les téguments vulvaires, on a les carcinomes épidermiques, les vésicaux, les mélanomes, les vasocellulaires, les pagées, et aussi les métastases.

Les glandes de Bartholin peuvent être le siège d'adénocarcinome ou même de carcinome épidermoïde. Puis les sarcomes peuvent concerner tous les tissus conjonctifs qui se trouvent au niveau de la vulve. Et pour les glandes sudorépa qui existent dans cette région, on peut avoir des tumeurs mixtes, on peut avoir des carcinomes adénoïdes qui stiquent.

Alors le cancer de la vulve, c'est un cancer qui est très influencé par un certain nombre de facteurs de risque, de facteurs pathologiques, et qui sont très variables. Tout d'abord, le virus HPV, c'est-à-dire Human Papilloma Virus, est généralement oncogène. Et c'est les stéréotypes 16 et 18.

Et on le retrouve dans 30 à 40% des cas, souvent chez des femmes inférieures à 60 ans, c'est-à-dire qui sont exposées à des âges précoces à l'HPV oncogène. Situation socio-économique faible, pourquoi ? Parce que on sait que les conditions d'hygiène et les infections répétitions constituent des micro-traumatismes qui permettent de réduire l'immunité locale, ce qui donne à l'HPV la possibilité d'infecter les pitériums. Et puis, les patients qui ont des comportements sexuels à risque, là où on voit des co-infections par plusieurs droits.

Puis, un des facteurs les plus retrouvés dans les cancers de l'HPV, c'est le lichen sclérose, qui est une pathologie particulière de l'HPV et qui donne une sclérose cutanée avec effacement des blis et un aspect blanchâtre et qui nécessite une surveillance très rapprochée, vu qu'il peut évoluer vers un cancer inresistible. D'autres facteurs de risque peuvent survenir, comme l'infection par le veillage. On sait que l'infection par le veillage a permis une repréence des cancers du col ou des cancers qui sont HPV sensibles, parce que l'infection d'un HPV oncogène persiste pendant longtemps, du moment que l'immunité est diminuée chez ces patients-là.

Le tabagisme, le diabète, l'hyperconcentré, puis la sclérose. Et donc, et surtout quand il s'agit de lésions par l'intermédiaire de l'HPV, par le virus HPV, le cancer invasif de la lune évolue presque de la même manière que le cancer du col ou du terrain, c'est-à-dire évoluer sur une longueur de 15 ans avant d'arriver à un stade invasif. Et donc, depuis un épithélium normal et avec la prénonce de l'HPV, il y a des atypies cellulaires, surtout des cellules banales de l'épithélium humain, qui vont commencer à apparaître et qui vont constituer les lésions intra-épithéliales.

Alors, on voit ici sur ce schéma que ça concerne les C.I.N., c'est-à-dire les cervicales intra-épithéliales néoplasmiqes, les V.I.N., c'est-à-dire les vulvaires intra-épithéliales néoplasmiqes, donc ça concerne la lune. Et puis les V.A.I.N., c'est les vagins, les vaginales intra-épithéliales néoplasmiqes. Et donc, de la même manière, ces C.I.N. vont passer d'un grade 1, où on parle de C.I.N.1, ou V.I.N.1, ou V.I.N.1, là où les atypies cellulaires de la cellule banale qui sont secondaires à l'invasion ou à l'action du virus HPV, eh bien, n'intéressent que le 1 tiers de cet épithélium.

Puis, elle va intéresser les 2 tiers et on parlera de C.I.N.2, V.I.N.2. Et puis les 3, elle va concerner les 3 tiers de l'épithélium et là on parlera de C.I.N.3, V.I.N.3, V.I.N.3, pour après traverser la

membrane banale et devenir invasif, en passant par l'étape du carcinome in situ, où la totalité de l'épithélium est atteinte par les atypies cellulaires de la cellule banale. Donc, voici un autre schéma qui montre la même chose et de gauche à droite, on voit l'évolution vers le cancer invasif. Ici, c'est l'exemple de C.I.N. mais c'est la même chose que pour le V.I.N. C.I.N. c'est cervical, c'est le colutérant.

V.I.N. c'est la lune. Donc, à partir de l'état normal et on voit là la différenciation de cellules épithéliales depuis la cellule basale jusqu'à la cellule superficielle qui est aplatie et qui perd son rayon et qui déforme, on voit que par l'intermédiaire ou par l'intervention de l'HPV, il y aura des atypies cellulaires qui vont concerner la cellule basale et qui va perdre son pouvoir de maturation pour constituer de l'hépithélium normal. Et donc, ces anomalies cellulaires basales vont d'abord intéresser le insuffer et c'est le C.I.N.1, et là on est dans l'illusion de la grâce pour l'école, pour atteindre les 2 tiers de l'hépithélium et c'est le C.I.N.2, pour atteindre les 3 tiers de l'hépithélium et c'est le C.I.N.3, et quand la totalité de l'hépithélium est atteinte, on pourra avoir le C.I.N.4. Alors, au moment où ces cellules atypiques traversent la membrane basale, et c'est l'extrême droite du schéma, ça devient un cancer invasif.

Qui dit un cancer invasif, dit qu'il va y avoir une atteinte du chorion, le chorion qui contient quoi ? Qui contient le vaisseau, qui contient de l'infratique, et donc ça va donner des métastases ganglionnaires avec l'infratique et des métastases à distance avec les vaisseaux saungas. La particularité dans l'histoire naturelle de la boule, du cancer de la boule, c'est que ce n'est pas comme le col, il y a une seule voie de survenue de ce cancer invasif du col, c'est la voie en utilisant l'HPV, d'accord ? Ou par l'intermédiaire de l'HPV en projet. Mais pour le cancer de la boule, il peut survenir même s'il n'y a pas d'infection à l'HPV, et ça c'est le cas particulier de la présence d'un lichens sclérose avant la survenue du cancer invasif.

Le lichens sclérose donne de l'hyperplasie épithérale et il va évoluer dans le temps vers le cancer invasif. Alors que l'infection HPV oncogène va donner l'évolution dont on en parlait tout à l'heure, VN1, VN2, VN3. Mais au niveau de la boule, ces VN1, et bien elles peuvent avoir d'autres noms, parce qu'elles ont des manifestations cliniques différentes par rapport à ce qui se passe au niveau du col, puisque dans le col il y a un seul type de structure histologique qui est l'épithélium epiglottis administratif, ou le nom kératinisé.

Mais au niveau de la boule, il y a le nom kératinisé, mais il y a aussi l'épithélium epiglottis kératinisé, et bien ça ne veut que c'est ce cas. Et donc, l'effet de l'HPV va donner une pathologie qui peut être différente cliniquement. D'abord, il y a ce qu'on appelle la maladie de Bowen, et puis la papulose Bowen-Hilde.

Alors ces deux lésions qui ont été décrites autrefois comme des entités particulières, ou des maladies particulières qui peuvent évoluer vers le cancer invasif, et bien actuellement ils sont classés dans le cadre des VIN, c'est-à-dire des myoplasies du verre intra-épithélial type 3, et on va voir comment, et qu'elles peuvent se transformer à des pourcentages différents vers un

cancer invasif de la boule. Donc, ceci rend les choses un peu plus compliquées au niveau de la boule, c'est pas comme au niveau du col, quand c'est simple, vous avez l'HPV, vous avez les lésions précancéreuses OVN1, OVN2, OVN3, mais pour la boule, on peut avoir cette évolution, HPV, OVN1, OVN2, OVN3, en sachant que ces OVN1, OVN2, OVN3 peuvent avoir des aspects cliniques différents et ils peuvent être appelés de façon spécifique, comme la maladie de Bowen ou la papulose Bowen-Hilde. Et en plus des lésions dépendantes de l'HPV, il y a des lésions précancéreuses de la boule qui n'ont aucun rapport avec l'HPV, comme le lichen sclérum.

Voici des exemples du lichen sclérum, donc à droite, en haut, on voit donc des zones, c'est une boule, mais c'est une boule, si vous remarquez, qui est complètement effacée, elle n'a rien à voir avec la boule que nous avons vue au tout début du cours, où nous avons les courants de lèvres, les petites lèvres, qui sont bien pliées, alors ici elles perdent toutes les plis, il y a un effacement de la boule, on ne voit plus les petites lèvres ni les grandes lèvres, le clitoris les concentre, et on voit en plus de ça des lésions blanchâtres autour du clitoris et des lésions rougesâtres tout autour. Dans la photo du bas, là aussi il y a un effacement des grandes lèvres avec des lésions blanchâtres sur les zones plus tannées, et on voit que les petites lèvres sont tellement fines, c'est qu'elles vont évoluer vers un effacement complet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mycène sclérose, et c'est une lésion qu'il faut guéter quand on examine des femmes très âgées, parce que parfois, il peut passer un aperçu, puisque des femmes très âgées qui n'ont pas de symptomatologie particulière ne peuvent pas se faire examiner de façon périodique, mais elles vont consulter nos comptes, ils auront un prurite et des douleurs ou des bourdure, et là, généralement, on voit un dégât à ce point-là, sachant qu'on peut traiter ce week-end par la corticothérapie.

Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique, en période post-ménopausique. Cliniquement, c'est un prurite avec bourdure, une disparité, et puis quand on regarde, évidemment, on retrouve des plaques blondes accrées, avec disparition des reliefs de la bourdure, et puis parfois, on peut trouver des signichis, des petites lèvres, plus ou moins évoluant, c'est-à-dire que les petites lèvres ont collé l'une contre l'autre, on peut en trouver un héritage autour, et parfois, ça peut être complètement asymptomatique comme l'idée, puisque c'est une lésion qu'on peut diagnostiquer en faisant des examens périodiques et systématiques aux patients. Pour faire le diagnostic confirmation, il faut faire une biopsie, avoir l'histologie pour diagnostiquer ce qui est faux, et puis généralement, même si on traite avec la corticothérapie, ça peut récidiver, et ça peut évoluer vers des lésions précancéreuses, et donc, peut donner un 5% des cas de carcinome épidermique.

Donc, c'est une lésion précancéreuse, mais qui n'est pas en relation avec l'infection expériure en COVID. Pour la maladie de Bowen, c'est des lésions vulvaires qui seraient chez des femmes ménopausées, là aussi, c'est des patients qui vont présenter des brûlures, un bruit, et ce qui est particulier à la maladie de Bowen, c'est que c'est une lésion unifocale, vous voyez sur l'image à droite, on voit des lésions un peu arrondies grossièrement, qui sont aussi blanches, et on parle

de mycoplasas, chaque fois qu'on a des lésions blanches, et elles sont en relief, c'est-à-dire, pas comme les canines, elles sont plates, mais là, elles sont en relief, et elles sont des lésions unifocales, et comme je dis, elles sont mycoplasiques, et polycycliques en périphérie. Pour retrouver une lésion pareille sur une vulva de femme empuagée, il faut là aussi faire le diagnostic par la biopsie, et généralement, ça nous donne un type de VIN3.

Donc, on parle de VIN3, mais au niveau de la vulva, concernant cet aspect-là, unifocale, polycyclique, mycoplasique, et en relief, ça s'appelle une maladie de Bowen. L'évolution, ça peut s'étendre en surface, et ça peut évoluer vers le carcinome épidermoïde, entre 20 et 30% en fonction de l'âge de la patiente. La papuleuse Bowenïde, la papuleuse Bowenïde aussi, alors là, c'est des patientes qui sont un peu plus jeunes, qui peuvent être abasiques, et parfois, immunodéprimées.

Les syncliniques, c'est un prolite, et on retrouve des papules grises ou brunâtres qui sont pigmentées, donc c'est une lésion multifocale. Ou bien, on peut retrouver des formations exophétiques verruqueuses, comme sur l'image, on peut les retrouver en bas. On verruqueuses, c'est parce que là aussi, elles sont en relief, mais elles ne sont pas mycoplasiques, elles ne sont pas blanches, elles sont plutôt brunâtres, elles grisent.

Et là, il faut faire attention aussi à des lésions comme ça, qui peuvent être asymptomatiques, comme elles peuvent donner un prolite. Et donc, là aussi, il faut les bioxyer pour faire le diagnostic de confirmation. Généralement, pour la papulose brunétiennne, elle est bénite dans 90% des cas, qui peuvent guérir spontanément ou après traitement, mais elle récidive dans 50% des cas, et entre elles, on a des lésions exceptionnelles chez les immunodéprimés.

Elles sont associées à l'infection HPV dans 80% des cas, et quand on a des lésions comme ça, il faut chercher des lésions condylomateuses, on ne peut faire qu'un overgenal, il faut faire un frottis et une goutoscopie, et chercher des lésions périanales ou même des lésions intracanalères, c'est-à-dire que c'est une lésion qui est HPV-dépendante dans 80% des cas. Donc, pour définir exactement les néoplasies intrafitaliales de la vulve, et c'est les VIN, vulva intra-hépitalial neoplasie, et bien la définition a été précisée en 2016 pour parler là aussi de VIN de bas grade et de VIN de haut grade, comme ce qu'on fait pour le cancer, c'est les lésions atypiques de bas grade et les lésions atypiques de haut grade, dont la conduite va changer par la suite. Les VIN de bas grade, c'est toutes les lésions atypiques intra-hépitaliales de bas grade, quand c'est bas grade, c'est VIN1, c'est condylome plan, et ils ont un faible risque de progression, on peut les traiter localement, si jamais elles sont localisées.

Puis, les VIN de haut grade, par rapport à la vulve, elles sont classées en deux types, les VIN classiques qui sont liées à l'HPV, et les VIN différenciées qui ne sont pas reliées ou qui ne sont pas liées à l'HPV. VIN classique ou liée à l'HPV, c'est les lésions multiliennes intra-hépitaliales de haut grade, donc c'est exactement la même chose que pour le col, et là, c'est les VIN2 ou 3 qui peuvent être la maladie Bowen, puisque la maladie Bowen est une VIN3, qui peuvent être les

savantes cliniques de la populo Bowen-Lewin, et ils sont liés à l'HPV immunopostale, avec une expression du protéine 16 en immunohistochimie, ils ont un risque d'évoluer vers un carcinome épidermique, et ils ont une forme multicentrique, ça peut être associé au vagin ou au col utérin. Puis, les VIN différenciées, qui ne sont pas liées à l'HPV, eh bien, ils ont un risque de progression qui est important, associant avec un carcinome épidermique ouvert ou peu, donc ils peuvent en même temps exister et être associés à un carcinome invasif.

Et ils peuvent aussi être associés avec un liché musculaire atrophique ou une hyperplasie ouverte. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a deux voies qui peuvent conduire à un carcinome épidermique de la bulbe. À gauche, il y a la voie qui fait intervenir l'HPV, et là, ça va donner les VIN classiques, l'ordre de 1, 2 et 3, et dans ce cadre-là, on claque la liboine ou la papuleuse bolinoïde, et donc, elles vont passer par les étapes pour arriver au carcinome épidermique invasif.

Du côté droit, il y a toutes les pathologies qui peuvent donner un carcinome épidermique de la bulbe sans l'intervention de l'HPV. Et là, par exemple, c'est l'image du liché sclérose, L-S, qui est l'image au milieu, et qui peut donner ce qu'on appelle les VINs différenciés, qui vont, là aussi, être VIN1, VIN2, VIN3, mais qui vont évoluer aussi vers le carcinome épidermique. Donc, c'est ça la particularité de la bulbe.

Il n'y a pas une seule voie qui conduit au cancer, il y a deux voies différentes qui peuvent exister. Donc, voilà, deux types de lésions intra-épithéliales de haut grade. Les VINs classiques, à gauche, qui font intervenir l'infection HPV, femmes un peu plus jeunes, généralement tabagiques, éliminées, déprimées, intervention d'HPV 16 sur tous les lits aussi, qui est positive dans 85% des cas.

Souvent, lésions multiples, plus ou moins étendues pour les morphes. Localisation, autres peuvent coexister, comme pour le col ou le vagin, et peuvent régresser spontanément pour les VIN1, surtout, s'il y a la grossesse ou s'il y a l'arrêt, par exemple, du tabagisme, qui donne donc une immunodépression. Et puis, ils ont un risque d'évolution à l'invasion relativement faible, de 20% à peu près, pas comme celles qui sont différenciées.

Et puis, après le traitement des VIN1, c'est-à-dire quand on fait les XRS de ces VIN1, il y a le risque et le récurrence, c'est-à-dire qu'il faut continuer à surveiller de la même façon. Pour les VIN différenciées, c'est des VIN qui ne font pas intervenir l'HPV et qui, souvent, c'est des femmes ménopausées avec un antécédent de liché musculaire. Pas de contre-indications d'HPV, comme je disais, lésions les plus souvent uniques, autres localisations rares et pas de régression possible, souvent, elle évolue à 80% de cas vers la maison.

Donc, voilà, on a expliqué l'histoire naturelle concernant le labrum et donc, on va voir l'aspect évolutif et clinique de ce cancer. Alors, quand il y a un cancer invasif, là, on ne parle plus des VIN ou des lésions pré-cancéreuses, on parle d'un cancer invasif, c'est-à-dire qui a déjà traversé la membrane basale, eh bien, il va évoluer, tout simplement, s'il n'est pas traité à temps. L'évolution

peut se faire localement, la tumeur devient épisoplitique ou chou-fleur.

Le site peut être variable, donc, ça peut être grandes lèvres, petites lèvres, clitoris, les cibules, mais les grandes lèvres sont les plus souvent intéressées. On peut avoir des lésions bilatérales, mais rarement on les retrouve dans les lésions avancées aussi. Lésions multifocales, entre 0 et 30% des cas, mais ça peut exister.

Ce qui peut exister aussi, c'est la co-existence de lésions invasives et de lésions pré-cancéreuses auxquelles il faut faire très attention pour les traiter ensemble. Et donc, l'extension se fera en profondeur, mais se fera en surface aussi, et donc, elle peut atteindre les vagins, elle peut atteindre les raîtres, elle peut atteindre la fosse ischio-révitale, elle peut atteindre les sillons génito-clurales. Plus tardivement et plus rarement, on peut enregistrer les fourchettes pulvaires et les canaux amortis.

Pour l'extension régionale, le cancer de la vulve est un cancer très lymphophile et il y a très souvent des métastases vers des ganglions inguinaux superficiels profonds qui sont séparés par un recette fibriforme. Ces métastases inguinaux peuvent se revenir dans n'importe quel site tumoral, au niveau ovulaire. Puis, il y a les métastases vers les ganglions iliaques externes et lombo-aortiques si atteintes centrales ou avancées.

L'envahissement isolé des ganglions péliens est très rare, mais de trois façons, et il est d'autant plus élevé que le nombre de ganglions envahis est élevé aussi par an. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'envahissement iliaque seul, mais il faut que les ganglions inguinaux soient déjà envahis, au moins trois, pour qu'on ait un envahissement iliaque externe. Alors un envahissement ganglionnaire bilatéral peut se faire, parce qu'il y a un riche réseau à l'ostomotique, et on va à 30% des cas si la lésion est strictement bilatérale.

C'est-à-dire que si on a une tumeur, on conserve du vectre dans les deux côtés, sur les deux rangs de lèvres, ils sont bilatérales. Là, ça se comprend qu'on ait un envahissement ganglionnaire bilatéral. Parfois, on va à 30% pour avoir une lésion unilatérale, mais on peut avoir un envahissement bilatéral.

Pour l'extension générale, ce sont les métastases à distance. Ils sont rares et tardifs, et ça intéresse le foie, le poumon et l'os. Donc, la taille de la tumeur, l'extension locale, l'extension régionale, l'extension générale, permettent de classifier les concerts de la boucle, selon la Figo 2019, en stades, qui vont de stade 1 à stade 4B, en fonction de la taille et de la localisation de la tumeur, et des métastases ganglionnaires.

Le stade 1, c'est généralement des tumeurs limitées à la bulbe et au perliminé, il n'y a pas de métastases ganglionnaires. Le stade 1A, c'est une tumeur qui est inférieure à 2 cm, limitée à la bulbe ou au perliminé, et invasion stromale inférieure à 1 mm. L'invasion stromale veut dire une invasion en profondeur, et pas de métastases ganglionnaires.

Ceci veut dire, déjà, qu'on a fait l'exérèse totale, et qu'on a mesuré exactement la profondeur, la largeur, et on a examiné histologiquement les ganglions. C'est une stagification après l'histologie, quelque chose qu'on ne peut pas faire en faisant uniquement la biopsie. Le stade 1B, c'est toujours une tumeur localisée, tumeur supérieure à 2 cm, limitée à la bulbe ou au préliminé, ou invasion stromale supérieure à 1 mm, mais toujours pas d'atteinte ganglionnaire.

Le stade 2, là, c'est une tumeur, quelle que soit sa taille, avec envahissement des structures périnéales adjacentes, notamment l'intérieur inférieur de l'oreille, l'intérieur inférieur du vagin, ou de l'anus, et pas de métastases ganglionnaires. Le stade 3, tumeur quelle que soit sa taille, avec ou sans envahissement des structures périnéales, mais métastases ganglionnaires, régionales, unilatérales. Dès qu'il y a une atteinte en N+, c'est-à-dire dans la classification TNM en N+, on passe à un stade 3. 3A, métastases d'un ou deux ganglions inférieurs à 5 mm, d'un ganglion supérieur à 5 mm.

Stade 3B, métastases de plus de trois ganglions inférieurs à 5 mm, ou plus de deux ganglions inférieurs à 5 mm. 3C, métastases de ganglionnaires avec effraction capsulaire. Le stade 4, comme souvent dans les tumeurs, c'est quand il y a des atteintes un peu plus à distance.

Envahissement tumoral d'autres structures régionales, plus de 2 tiers de l'urètre, plus de 2 tiers du vagin, la vessie, la veuveuse rectale, le baffin, ou métastases à distance. Le 4A, c'est associé à une métastase de ganglionnaires fixe ou serrée, et 4B, métastases à distance incluant les ganglions péliens. Quand les ganglions péliens sont atteints, c'est une métastase à distance.

Ces classifications en matière de concert sont nécessaires pour stagifier ou pour décider de la conduite à tumeur. Alors, sur le plan clinique, comment étudier ou comment faire les diagnostics en prise en charge d'un cancer de la veuve ? On prend en type de description le carcinome épidémiologique qui est le plus fréquent. Sur le plan clinique, les signes fonctionnels pour lesquels la patiente consulte, c'est un progrès, c'est un sagement, une disparition.

Et quand on examine, on doit examiner soigneusement l'ensemble de la veuve puisque l'on a vu que la maladie peut être plurifocale et surtout les lésions précancéreses peuvent être plurifocales. Bien évidemment, on peut avoir une association des lésions invasives et des lésions néoplasiques intraépithéliales, les VIM. Il faut déterminer l'ensemble des caractéristiques de la lésion ouverte, la localisation, ce que c'est du côté droit, côté gauche, antérieure, postérieure, centrale, la taille, la mobilité de la tumeur par rapport au plan sous-jacent, pour voir si elle est fixe ou mobile, l'extension ou voisinage, méia-urétrale, marginale, paroivaginale.

Et puis, on va faire un examen du col, déjà macroscopiquement pour chercher s'il y a des lésions macroscopiques et sinon on fait une cytologie type francicervico-originale et après l'examen HPE. On devrait faire aussi l'examen du vagin et de la marge anal-escanarale. Puis l'examen de palpation visaconglionnaire, animal, examen rétrofloral et sus-claviculaire.

Donc, au général, on peut reproduire les éléments de l'examen clinique sur un schéma comme celui-là. Alors, donc, de gauche à droite et de haut en bas pour trouver des schémas qui montrent une coupe frontale, par exemple, et sur laquelle on peut dessiner la taille de la tumeur et l'importance de l'enveuillement en hauteur et en profondeur. En bas et à gauche, c'est une coupe sagittale sur laquelle aussi on peut dessiner la teinte d'avant en arrière de l'urètre, du clitoris, des parois vaginales intérieures et postérieures, du col du terrain.

Puis, sur le schéma au milieu, au centre, on peut dessiner les gonglions sous-esclaves et en bas et à droite, on peut dessiner les gonglions inguinaux, donc unis, bilatérales. Et en haut, donc, ça c'est un schéma en haut et à droite, un schéma de la vue sur lequel on peut aussi dessiner la localisation de la lésion et puis sa taille par rapport à la taille de la vue, la teinte de la lèse, la teinte de l'avant et du clitoris. Donc, voilà des images du tumeur invasif de la boulevard.

Donc, à gauche, on voit donc lésion bourgeonnante qui intéresse les deux parties postérieures, des ingrowns de lèvres et des petites pierres de façon bilatérale avec atteinte de la tranchette postérieure et elle est en contact avec le refus à main. Au milieu, on retrouve une lésion qui est un peu rouge, qui est en relief aussi, qui est unilatérale et qui est mise en petits détails et qui intéresse donc la petite lèvre et la pointe de lèvre à droite. Mais on voit qu'il y a des lésions un peu papuleuses de l'autre côté qui peuvent être des lésions préconçantes du trubux.

Alors, sur la lésion droite, on voit qu'il y a une tumeur qui est en chou-fleur, donc qui est centrale et qui prend le clitoris et qui est un peu écartée d'onglet par ongle. On a situé une lésion centrale. On n'a pas de viscée derrière, donc l'image ne le montre pas.

Donc, cliniquement, on a fait l'examen, on a situé la lésion, on a vu la taille, on a vu les caractéristiques cliniques. Maintenant, il faut confirmer d'abord le diagnostic et c'est le seul moyen de la biopsie. Donc, on fait une biopsie, on prend un petit morceau de la lésion et on l'envoie à l'analyste pour qu'elle l'analyse.

Donc, ceci nous donne une confirmation histologique du diagnostic et on peut faire, par exemple, pour en chercher de l'HPV, on peut faire aussi une copioscopie de biopsie pour chercher les anomalies serviteurs. Après, on devrait faire un bilan d'extension pour pouvoir savoir on est à quel stade de la maladie. Et donc, ceci dépend de la localisation de l'acumule et de sa taille.

On peut faire une rétrocystoscopie si on suspect qu'il y a une pointure vitrale ou vésicale. On peut faire une anuscopie, une rectoscopie si on suspect une atteinte en canard ou USC-Ode. On peut faire une échographie inguinale avec cette fonction biopsie ganglionnaire pour savoir s'il y a une atteinte ganglionnaire d'anglais.

L'ATDM abdominal, thoracoabdominopélien, ce qu'on dit dans le TAP, pour un bilan d'extension ganglionnaire en Bois-Arctique avec des lésions secondaires, notamment le foie, le poumon. On peut demander l'IRM pelvienne qui va permettre un bilan d'extension tumoral local et ganglionnaire

puisque l'IRM est très performante en matière de pelvis. Donc, elle peut nous donner exactement, si on n'arrive pas à déterminer la hauteur exacte de l'envahissement sur le vagin ou l'atteinte paramétriale ou l'atteinte des processus tuyaux en vitale, on peut faire une IRM qui va nous donner une cartographie précise.

Puis, le TAP scanner ou le PET scan qui est une tomographie oppositant, eh bien, on peut l'utiliser dans les formes localement avancées, c'est-à-dire 2, 3, 4, ou quand on a une adénopathie M1 en train de chercher les métastases existants. Avant d'intervenir chirurgicalement ou pour les traitements existants, on devrait faire un bilan d'opérabilité puisque ce sont des patientes qui sont généralement d'âge avancé. Donc, on va évaluer précisément les comorbidités avec la présence de risques thrombotiques, la mobilité, le diabète, etc.

On doit faire une constatation préanesthésique et puis une évaluation de la cause gériatrique pour savoir est-ce que cette patiente a supporté la chirurgie lourde ou la chirurgiothérapie ou la radiothérapie. Alors, il y a des formes cliniques. On a vu l'aspect clinique d'un cancer épidermoïde.

On peut avoir d'autres formes cliniques liées essentiellement au type histologique, notamment les carcinomes verruqueux. Ils peuvent devenir très volumineux. Ils ont une surface irrégulière et hémorragique.

Souvent, il y a des antécédents de condylomes vulvaires. Une évolution locale en surface plus en profondeur peut atteindre la glande recto-vaginale, la région péri-urétrale. Et il n'y a pas de métastase ganglionnaire ou à distance.

Les carcinomes glandulaires primitifs, ils concernent les glandoblastomes, c'est les aminocarcinomes de glandoblastomes. Ils peuvent donner des métastases ganglionnaires précoces. Les sarcomes, c'est des tumeurs conjonctives exceptionnelles.

Selon le type histologique, le pronostic est très variable, allant des formes à évolution lente aux formes à évolution métastatique rapide. En fait, les sarcomes, c'est parmi les cancers les plus imprévisibles. Il y a certains types qui sont très méchants et d'autres qui évoluent plus lentement.

Et donc, après avoir fait le diagnostic concernant la vulve, et après avoir précisé le type histologique, l'extension et le stade, on doit penser aux moyens thérapeutiques et à la stratégie thérapeutique en général. Quels sont les moyens dont on dispose pour traiter les formes de la vulve? Eh bien, premièrement, c'est la chirurgie de la tumeur. C'est ce qu'on appelle les vulvectomies.

Soit une vulvectomie totale, profonde, qui va jusqu'à la préhospitalité artificielle. Et donc, on enlève toute la structure en dessous. La vulvectomie partielle, et là, on fait une légersse large de la lésion, en conservant le reste avec une marge centimétrique de moins de 2 cm cliniquement, macroscopiquement.

Puis, il y a l'exantération pénivienne. C'est quand il y a atteinte soit de la durette, la vessie ou de l'anus du canal anal. Eh bien, là, légers encore plus large, puisqu'on va enlever en même temps la vulve, mais aussi la durette ou la vessie et l'anus.

Et là, la patiente va avoir des procédés d'évacuation abdominales comme les colostomies ou les cystostomies. L'utilisation de techniques de chirurgie conservatrice et reconstructrice peut aussi être utilisée dans la vulve quand il y a une grande perte de substances afin de couvrir les parties cutanées. Voici des exemples de la vulvectomy.

Comme A, c'est une vulvectomy partielle antérieure. On enlève partie d'autre de glotonie, sa grande lèvre. B, c'est une vulvectomy latérale.

On enlève la tumeur avec partie de la grande lèvre. Postérieur, on enlève la fourchette anale. Ici, c'est une chirurgie avec reconstruction vulvaire, puisqu'on a une grande surface qui contient des lésions multiples.

On peut regarder l'image à gauche. Elles sont entourées de façon à ce qu'on va enlever tout ça. Si on enlève tout ça, on va avoir des problèmes de couverture de cette zone pour ne pas fermer de façon continue.

Donc, on rapproche un peu la peau sur les triangles dessinés du côté droit et gauche et on les rapproche vers la ligne médiane afin de combler cette partie-là. Deuxième moyen thérapeutique, c'est la chirurgie des gonglions. On a vu que c'est un cancer qui est très lymphophile.

La procédure du gonglion sentinelle peut avoir sa place aussi dans les cancers de la glufe. Je pense que vous avez déjà vu avec nous ça. C'est-à-dire qu'en injectant un produit colorimétrique ou un produit isotope, on cherche les premiers relais gonglionnaires qui doivent être prélevés et envoyer à l'anthropatologiste immédiatement.

Si elles sont positives, on sait qu'il y a un risque que le reste des gonglions soient aussi envahis. Mais si ils sont indemnes et non envahis, on peut se passer du courage de ne pas faire le curage gonglionnaire. Cette procédure se fait par méthodes combinées, colorimétriques et isotopiques, unies ou bilatérales, pour une taille tumorale inférieure à 4 cm et absence d'adénopathie prouvée.

C'est-à-dire qu'on a fait une échographie du dépli et l'immunose. On n'a pas trouvé d'adénopathie suspecte. Si on la trouve, généralement, la cancére ou la biopsie en envoie à l'infarct.

Et sinon, on fait le gonglion centenaire. Si la lésion, donc on peut faire le gonglion centenaire ou si la lésion est à moins de 1 cm de la ligne médiane, l'évaluation gonglionnaire par la technique gonglion centenaire doit être réalisée de deux côtés. C'est-à-dire qu'on va prélever du côté droit et du côté gauche.

Après, il y a les lymphadenectomies fémoro-inguinales, c'est-à-dire qu'on va enlever les gonglions du groupe superficiel et profond au niveau fémoro-inguinal, à plus ou moins l'isolement du gonglion rétroclural de colocule. On va le faire de façon unie ou bilatérale, en fonction de la lésion. Mais souvent, on fait un tournage bilatéral.

Et il faut avoir au moins 8 gonglions. Lymphadenectomie iliaque externe et lombo-aortique peuvent être indiqués quand il y a des gonglions identifiés à l'imagerie ou bien quand il y a une atteinte massive des gonglions inguinaux. Sur ce schéma, on explique la position des gonglions inguinaux.

Sur le schéma en haut et à gauche, c'est une coupe transversale qui passe par la veine saphrène. Au numéro 1, on retrouve le facial du canthère. Après, au numéro 2, c'est la veine saphrène interne qui est un repère dans le curage gonglionnaire et qu'on doit respecter au maximum.

Et en rose, numéro 3, ce sont les gonglions inguinaux superficiels. Puis, il y a le facial cribriforme qui est perforé et que normalement, on devrait ouvrir au cours du curage pour avoir accès à la veine fémorale. Et autour de cette veine, autour de l'inflation de la veine saphrène, on peut trouver les gonglions inguinaux profonds.

En bas et à gauche, le facial cribriforme n'est pas encore ouvert et on retrouve la veine saphrène avec les gonglions inguinaux superficiels. À droite et en bas, on montre la veine saphrène comment elle s'introduit dans le triangle du scarpa qui constitue le repère de ce curage. Les autres moyens thérapeutiques en matière de cancer de la veine c'est la radiothérapie.

Elle est en deuxième par rapport à la chirurgie parce que la chimiothérapie n'a pas beaucoup de place dans la veine sauf dans les cas très avancés et qui dépasse les ressources chirurgicales et radiothérapiques. On fait une irradiation périenne externe avec une dose qui va de 45 à 50°C en 5 semaines avec ou non une chimiothérapie concomitant de potentialisation. La dose de 66 à 70°C sur la tumeur et les gonglions peut être indiquée si on va faire une radiothérapie exclusive donc il n'y a pas de place de chirurgie parce que la tumeur est très importante.

Si l'héberge après la chirurgie reste positif il n'y aura pas de possibilité de reprise. Les marges histologiques inférieures à 8 mm n'ont l'absence aussi de possibilité de reprise chirurgicale. S'il y a des embols ou d'infiltration en profondeur inférieure à 5 mm parce que la vulvectomie ne peut pas aller à plus de 5 à 8 mm en profondeur et donc si on a une infiltration en profondeur de 5 mm on devrait indiquer la radiothérapie.

La purithérapie en général c'est une purithérapie interstitiale mais qui doit être discutée en RCP en fonction du stade. Pour la chimiothérapie en matière de cancer de vulve c'est à la base d'un sel de platine 5-FE qui est généralement utilisé pour potentialiser l'action de la radiothérapie sinon située souvent dans les cas de la chimiothérapie palliatif. Palliatif c'est-à-dire que l'objectif

attendu est souvent une stabilisation des lésions sans espérer une rémission complète vu qu'il y a des métastases vu que le tumeur est très développé ou carrément quand il y a une répétitive par exemple en vulve.

Certaines indications selon la classification de la figure comment traiter le cancer de la vulve Pour le stade 1A, on peut faire une vivectomie partielle avec une marge à 5 mm sans curage congénial. Au stade 1B, quand c'est une lésion latérale on peut faire une hemivivectomie latérale et là on doit chercher des marges jusqu'à 2 cm avec une intradiméctomie fémuro-alignée. Une lésion médiane, on peut faire une hemivivectomie antérieure ou postérieure en fonction de la localisation avec une infadémictomie fémuro-inguinale et l'infadémictomie iliapecterne si atteint d'une clé staurée et s'il y a la présence de gonglions sur la TDM.

Puis, radiothérapie inguinale si exérèse est complète mais les gonglions sont en veille. Bien évidemment, radiothérapie sur le lit tumoral si l'exérèse n'est pas complète comme on avait dit ou s'il y a un envahissement profond. Les stades 2 et 3, où l'attente est plus importante l'exérèse est possible, on fera une lévectomie totale Si l'exérèse est impossible d'emblée, on préconise un traitement néoadjuvant néoadjuvant c'est avant la chirurgie qui associe une chimothérapie à base de cisplatine une radiothérapie qui peut aller jusqu'à 45 degrés quand on y prend et puis la chirurgie viendra après en fonction de la réponse si il y a une bonne réponse avec réduction de la masse tumoral on peut faire une chirurgie secondairement sinon on continue avec le même traitement puis la lymphodélectomie ou la radiothérapie si les gonglions sont fixés si les gonglions sont fixés, cela veut dire que chirurgicalement on ne peut pas les retirer parce qu'il y a des risques de blessures vasculaires puisqu'elles sont fixées généralement en dessous du tumoral.

Le stade 4, si nous avons une atteinte étendue ou une métatase d'insistance, généralement c'est une radiothérapie exclusive on peut faire de l'exvntération pélienne chirurgie de propreté uniquement pour enlever le tumoral nécrosis s'il existe et puis la chimothérapie palliation Pour les cas histologiques particuliers pour le mélanome malin par exemple puisqu'on avait vu qu'on pouvait avoir beaucoup de formes histologiques le traitement repose sur l'exérèse large et complète de la léumine en cas de gonglion palpable, il faut pratiquer l'exérèse secondaire et si nécessaire faire le curage inguinal crural complet puis une chimothérapie est indiquée en cas de métatase Le carcinome verruqueux, on a dit qu'il peut atteindre des tailles très importantes le traitement chirurgical doit être domblé et être très large c'est généralement une euvectomie totale récidive et fréquente, pouvant conduire de proche en proche à des interventions de plus en plus mutilantes Le carcinome vasocellulaire vulvaire, l'exérèse complète de la lésion et il n'y a pas d'indication à un curage gonglionnaire Le carcinome glandulaire primitif, le traitement est supposable à celui du cancer étulièremment vide c'est-à-dire en fonction de la stagification de la figure Puis les sarcomes, les sarcomes reposent aussi sur l'exérèse chirurgicale large soit hémivulvectomie ou vulvectomie, mais pas besoin de faire un curage gonglionnaire Après la prise en charge thérapeutique, les patientes doivent bénéficier d'une surveillance rapprochée

notamment tous les 3-4 mois pendant 1 an, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, puis tous les ans. Puis on devrait faire un scanner TAP thoraco-abdominopélvien si la tumeur était localement avancée et où il y avait des ganglions positifs. On fera ça tous les 6 à 12 mois pendant 2 à 3 ans. Puis le PET scan doit être réalisé en cas de suspicion de récidive ou de métastase. Alors le pronostic, le pronostic de ces tumeurs de la lune dépend essentiellement du stade au moment du diagnostic. Le pronostic dépend de la teinte ganglionnaire, ainsi que d'une norme de ganglions envahie. Puis une tumeur de moins de 2 cm est bien évidemment de meilleur pronostic. La profondeur de l'invasion aussi constitue un élément de bon pronostic. Plus l'envahissement de profondeur est moindre, plus le traitement est efficace, surtout le traitement chirurgical. Le type histologique est véritablement meilleur pronostic, même s'il y a des tailles très importantes. Le mélanome est de très mauvais pronostic. Le délai de récurrence ganglionnaire est supérieur à 2 ans et de meilleur pronostic. Cela veut dire que les patientes qui font des récurrences ganglionnaires dans moins de 2 ans, sachez que le pronostic s'aggrave et s'assombrit. Enfin pour la prévention, est-ce qu'on dispose de moyens de prévention des cancers de la vulve ? Eh bien, parmi les moyens de prévention primaires actuellement, c'est la vaccination anti-HPV. Le traitement des lésions pré-cancéreuses, il faut d'abord les diagnostiquer à temps. Puis on peut les traiter par des moyens médicaux comme l'imiquimod. On peut les traiter par vaporisation laser et les détruire. On peut aussi les traiter par la cryothérapie et les détruire comme on peut en faire de l'exérèse. Quand on traite les lésions pré-cancéreuses, notamment les VIN, et c'est la même chose que pour l'éczéma, on coupe le chemin sur l'évolution vers l'invasion. Mais on devrait continuer à surveiller les patientes parce qu'elles peuvent faire des lésions dans d'autres localisations. On traite les lésions pré-cancéreuses mais on continue à surveiller de près ces patientes. Voilà pour le cancer de la vulve, je vous remercie.